



BEHAVIOR HUB

DADOS. COMPORTAMENTO. INTELIGÊNCIA.

Addendum de Melhorias — Revisão de Produto v2.1
Consolidação das solicitações de ajuste identificadas
em uso, prontas para desenvolvimento

Produto	Behavior Hub
Documento	Addendum de Melhorias v2.1
Referência	Behavior Hub PRD v2.0 (15/07/2026)
Status	Pronto para implementação via Claude Code, salvo pontos assinalados na Seção 3
Data	20 de julho de 2026

Documento confidencial — uso interno do time de produto e engenharia do Behavior Hub.

Sumário

1. Contexto e como usar este documento	
2. Requisitos detalhados (RF-01 a RF-17)	
3. Decisões confirmadas (RF-07, RF-13, RF-16)	
4. Impacto no modelo de dados	
5. Impacto em personas e permissões (papel "AT")	
6. Prompt pronto para o Claude Code	

1. Contexto e Como Usar Este Documento

Este addendum traduz 17 pontos de melhoria identificados no uso do protótipo do Behavior Hub em requisitos funcionais claros, testáveis e prontos para implementação. Cada requisito referencia a seção correspondente do **PRD v2.0** que ele altera ou complementa, para que nada seja implementado de forma desconectada do restante do sistema.

Três dos pontos originais (RF-07, RF-13 e RF-16) tinham ambiguidade ou entravam em conflito direto com regras já definidas no PRD. Eles já foram esclarecidos com você e aparecem detalhados como **decisões confirmadas** na Seção 3 — o restante do documento já reflete essas decisões.

2. Requisitos Detalhados

RF-01

Marca · Seção 5 e 23 do PRD

Solicitação: adicionar a logo no título (aba do navegador) e na tela inicial de login.

Comportamento esperado: favicon com a versão reduzida do símbolo (Seção 23.7) em todas as páginas; tela de login com o logotipo vertical centralizado (Seção 23.8), acima dos campos de e-mail e senha.

Critério de aceite: a aba do navegador exibe o ícone da marca em qualquer tela do sistema; a tela de login exibe o logotipo completo antes de qualquer conteúdo de formulário.

RF-02

Nomenclatura · Seção 9 do PRD

Solicitação: renomear "Dashboard" para "Área de Trabalho" em toda a interface.

Comportamento esperado: alterar o rótulo no menu lateral, nos títulos de página, em breadcrumbs e em qualquer referência textual — inclusive em e-mails e notificações que mencionem a tela. Manter o mesmo conteúdo e função descritos na Seção 9 do PRD; é uma alteração de rótulo, não de comportamento.

Critério de aceite: busca por "Dashboard" no código de interface não deve retornar nenhum texto visível ao usuário.

RF-03

Pacientes · Seção 10.1 do PRD

Solicitação: visual mais dinâmico na aba Pacientes, com campos cadastrais adicionais: endereço, telefone, nome da escola e turno escolar, além do nome do responsável (que já constava no PRD original).

Comportamento esperado: expandir o formulário de cadastro/edição de paciente com os novos campos abaixo. O card de paciente na listagem (Seção 25 — wireframes) ganha uma leitura mais rica: foto/avatar, nome, idade, badge de status, e um resumo rápido (escola + turno) sem precisar abrir o cadastro completo.

Campo novo	Tipo	Obrigatório
Endereço	Texto (rua, número, bairro, cidade, CEP)	Não
Telefone	Texto com máscara de telefone	Não
Nome da escola	Texto	Não
Turno escolar	Seleção: Manhã / Tarde / Integral / Não frequenta	Não

Nota de privacidade: endereço e telefone são dados pessoais sensíveis sob a LGPD (Seção 17.2 do PRD); devem seguir as mesmas regras de criptografia em repouso e controle de acesso já previstas para diagnóstico e demais dados clínicos.

Critério de aceite: cadastrar um paciente com todos os campos novos preenchidos, reabrir o cadastro e confirmar que os dados persistiram corretamente; campos ficam ocultos para perfis sem permissão de leitura de dados pessoais.

Card de paciente — antes e depois

Antes: avatar + nome + idade + diagnóstico + badge de status, sem mais contexto.

Depois: mesmo card, com uma segunda linha discreta mostrando escola + turno (ex.: "Escola Girassol · Manhã"), e um ícone de telefone/endereço que abre os dados completos sem precisar entrar no cadastro — mantém a leitura rápida do card e ainda entrega mais contexto de relance.

RF-04

Plano de Tratamento · Seção 13 do PRD

Solicitação: na página do paciente, aba Plano de Tratamento, adicionar a opção de importar um PDF por área (Psicologia, ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional etc.).

Comportamento esperado: em cada coluna de área da grade multidisciplinar (Seção 13.1), adicionar um botão "Importar PDF" que anexa um documento àquela área específica do plano — por exemplo, uma avaliação externa ou um plano terapêutico já existente em papel. O PDF fica listado como anexo da área, com data de upload e autor.

Critério de aceite: importar um PDF em "ABA" não o torna visível nem editável nas demais áreas; o arquivo abre no visualizador seguro já previsto na Seção 15 (Recursos Terapêuticos) para qualquer documento do sistema.

RF-05

Plano de Tratamento + IA · Seção 13.1 e 14.5 do PRD

Solicitação: dentro de "Novo Objetivo", vincular a IA para que, a partir do PDF exportado/importado (RF-04), ela crie automaticamente as estratégias, o critério de domínio e a descrição do objetivo.

Comportamento esperado: ao anexar um PDF na tela de Novo Objetivo, um botão "Preencher com IA" extrai o conteúdo do documento e sugere automaticamente: título do objetivo, descrição, estratégias e critério de domínio. O profissional sempre revisa e edita antes de salvar — a IA nunca publica um objetivo clínico sem confirmação humana, mantendo a regra já estabelecida na Seção 12.1 do PRD ("a IA pode gerar rascunhos, mas não deve publicar automaticamente conteúdo clínico sem revisão").

Ponto técnico de atenção

Extrair estrutura clínica confiável de um PDF variado (formato livre, escrito à mão escaneado, etc.) é a parte mais incerta deste requisito. Recomenda-se começar oferecendo o texto extraído do PDF como sugestão de preenchimento simples (a IA lê o texto e tenta mapear para os 4 campos), evoluindo depois para extração mais sofisticada conforme o volume real de documentos usados pelas clínicas.

Critério de aceite: ao clicar em "Preencher com IA" com um PDF anexado, os 4 campos do objetivo são preenchidos como rascunho editável, com um indicador visual "Gerado por IA — revise antes de salvar"; salvar sem revisão nenhuma ainda é permitido, mas o rascunho nunca é salvo automaticamente sem essa ação explícita do usuário.

RF-06

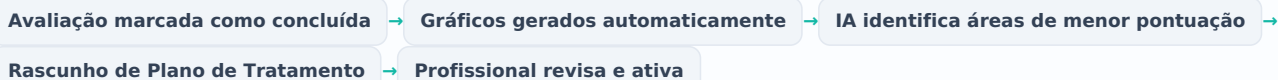
Avaliações Padronizadas + IA · Seção 30 do PRD

Solicitação: na aba Avaliações Padronizadas, ao finalizar uma avaliação, a IA gera automaticamente os gráficos e um plano de tratamento em modelo simples.

Comportamento esperado: ao marcar uma avaliação (ex.: VB-MAPP) como concluída, o sistema: (a) gera os gráficos de domínio a partir do `raw_scores` já normalizado (Seção 30.1.1), e (b) propõe um rascunho de Plano de Tratamento com objetivos básicos por área, com base nos domínios de menor pontuação identificados na avaliação. Esse plano rascunho é sempre editável e precisa ser aprovado pelo profissional antes de se tornar o plano ativo do paciente — nunca substitui um plano já existente sem confirmação explícita.

Critério de aceite: ao finalizar uma avaliação de teste com pontuações conhecidas, o sistema exibe os gráficos corretos (Seção 30.2) e apresenta um plano rascunho com pelo menos um objetivo por área de menor desempenho, marcado como "Gerado por IA — revise antes de ativar".

Fluxo Avaliação → IA → Plano



RF-07

Atendimentos · Seção 11.2 do PRD — **decisão confirmada, ver Seção 3**

Solicitação (como recebida): "adicionar a especialidade. Na ficha do paciente, além de ter que escolher por múltipla escolha a opção do terapeuta, escrever o nome do paciente."

Decisão confirmada: quando o atendimento é criado a partir da própria ficha do paciente (fluxo reorganizado pelo RF-09), o campo Paciente aparece como texto fixo (somente leitura), já que o contexto veio da navegação — não é uma nova digitação. O que é obrigatório por múltipla escolha é o Profissional/Terapeuta responsável, com a especialidade exibida junto ao nome (ex.: "Ana Ribeiro — Psicóloga infantil"), conforme já previsto na Seção 11.2 do PRD.

RF-08

Atendimentos · Seção 11.2 e 32.10 do PRD

Solicitação: remover a parte de cobrança da sessão dentro da aba Atendimentos.

Comportamento esperado: remover qualquer campo de valor, status de pagamento ou cobrança por sessão da tela de Novo Atendimento e da listagem de atendimentos. Isso reverte a proposta de Faturamento por Sessão (Seção 32.10 da versão anterior deste PRD) — consistente com a remoção da aba Faturamento pedida no RF-16.

Critério de aceite: a tela de atendimento não exibe nenhum campo relacionado a valor cobrado, forma de pagamento ou status de fatura.

RF-09

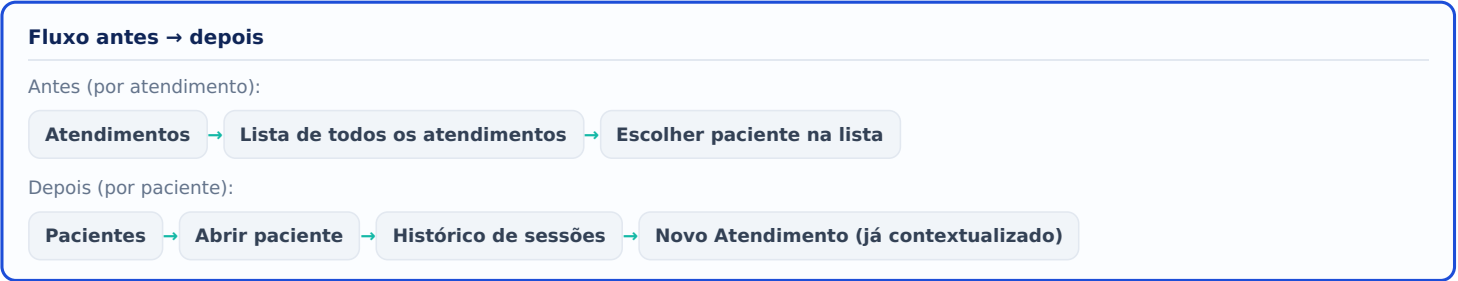
Atendimentos · Seção 10.2 e 11.1 do PRD

Solicitação: selecionar atendimentos por paciente, e não por atendimento.

Comportamento esperado: a navegação principal deixa de ser uma lista plana de todos os atendimentos da clínica. O fluxo passa a ser: Pacientes → abrir o paciente → aba "Histórico de Sessões" dentro da ficha dele (já prevista na Seção 10.2) → botão "Novo Atendimento" já parte do contexto daquele paciente específico. A lista global de atendimentos (Seção 11.1) pode continuar existindo como uma visão administrativa/de supervisão, mas deixa de ser o ponto de entrada principal do fluxo do dia a dia do terapeuta.

Critério de aceite: a partir da ficha de um paciente, é possível ver todo o seu histórico de sessões e iniciar um novo atendimento

sem precisar selecionar o paciente novamente em nenhuma outra tela.



RF-10

Training Library · Seção 12 do PRD

Solicitação: renomear "Training Library" para "Biblioteca de Treino". Adicionar botão "Novo Treinamento" para criar e salvar treinos próprios. Ao clicar em um treino, um botão "Vincular" abre uma aba com todos os pacientes cadastrados e uma barra de busca, para atrelar aquele treino a um paciente específico.

Comportamento esperado: "Novo Treinamento" reaproveita o formulário de estrutura de treino já definido na Seção 12.2 (título, categoria, objetivo, instrução discriminativa, resposta esperada, hierarquia de ajuda, critério de domínio, observações). O botão "Vincular" cria uma nova associação treino↔paciente (uma entidade nova, ver Seção 4 deste documento), permitindo montar uma lista de "treinos prescritos" para aquele paciente, sem precisar esperar a próxima sessão para escolher esse treino manualmente.

Critério de aceite: vincular um treino a um paciente faz esse treino aparecer destacado (ex.: "Prescrito") na tela de Novo Atendimento daquele paciente específico; a busca de pacientes dentro do modal de vínculo funciona por nome parcial.



RF-11

Novo módulo · Seção 2 e 17.1 do PRD

Solicitação: nova aba "ABA", acesso do supervisor, onde os ATs (Auxiliares/Assistentes Terapêuticos) aplicam os treinos; a Biblioteca de Treino fica vinculada a essa área.

Comportamento esperado: criar um novo papel de usuário, **AT (Auxiliar Terapêutico)**, com permissões mais restritas que Profissional: o AT vê apenas os pacientes atribuídos a ele, e dentro de cada um vê somente os treinos vinculados (via RF-10) que precisa aplicar — sem acesso a diagnóstico completo, plano de tratamento ou relatórios, salvo configuração em contrário do supervisor. A aba "ABA" é o espaço de trabalho do supervisor para: atribuir ATs a pacientes, acompanhar quais treinos foram aplicados por qual AT e quando, e revisar as tentativas registradas pelos ATs antes de estas influenciarem indicadores clínicos, se a clínica optar por essa camada de revisão.

Papel	Visualiza	Não visualiza
AT	Pacientes atribuídos, treinos vinculados a eles, tela de registro de tentativas	Diagnóstico completo, plano de tratamento, relatórios, dados de outras áreas
Supervisor (aba ABA)	Todos os ATs da equipe, atribuições, treinos aplicados, tentativas registradas	Configurações administrativas de faturamento/assinatura da clínica

Critério de aceite: um usuário com papel AT, ao logar, só vê a aba "ABA" e os pacientes/treinos atribuídos a ele — nenhuma outra aba do menu principal fica visível.



RF-12

Recursos Terapêuticos + IA · Seção 15 do PRD

Solicitação: na aba Recursos, adicionar botão de criar recurso por IA.

Comportamento esperado: botão "Criar recurso com IA" abre um formulário simples (tipo de recurso: história social, rotina visual, cartão de comunicação; tema; faixa etária) e gera um rascunho de recurso terapêutico em PDF ou texto, que o profissional revisa, edita e só então publica na biblioteca de recursos — nunca published automaticamente, seguindo o mesmo princípio de revisão

humana já aplicado em outras áreas de IA do PRD.

Critério de aceite: um recurso gerado por IA aparece com o badge "Gerado por IA — revise antes de publicar" até que o profissional confirme explicitamente a publicação.

RF-13

Remoção de funcionalidade — **decisão confirmada, ver Seção 3**

Solicitação: excluir a aba "Importar Paciente".

Decisão confirmada: a funcionalidade não é removida do código — fica oculta do menu principal por padrão, disponível apenas para clínicas Enterprise que precisem migrar de outro sistema (Seção 3 detalha a implementação recomendada via feature flag).

RF-14

Auditoria · Seção 17 do PRD

Solicitação: na aba Auditoria, adicionar o nome do paciente; ao clicar no nome, mostrar tudo o que foi feito por todos os profissionais.

Comportamento esperado: a listagem de auditoria (hoje organizada por ação/ator, conforme AuditLog da Seção 18) passa a ter também uma visão agrupada por paciente. Clicar no nome do paciente abre uma linha do tempo consolidada com todas as ações registradas por qualquer profissional sobre aquele paciente: criação/edição de sessões, alterações de plano, exclusões, restaurações, uploads. Esta visão reaproveita a estrutura de Timeline Clínica já definida na Seção 29.2 do PRD, mas com foco em auditoria (quem fez o quê e quando) em vez de foco clínico.

Critério de aceite: ao clicar em um paciente na aba Auditoria, todas as ações de todos os profissionais sobre aquele paciente aparecem em ordem cronológica, com autor, ação e timestamp visíveis.

RF-15

Segurança · Seção 6.3 do PRD

Solicitação: na aba Segurança, adicionar funções de troca de senha e nome de usuário.

Comportamento esperado: tela de autoatendimento onde o próprio usuário troca sua senha (exigindo senha atual + nova senha + confirmação) e seu nome de usuário/exibição. Trocar a senha deve encerrar as demais sessões ativas do usuário, conforme já previsto na Seção 6.3 do PRD.

Critério de aceite: após trocar a senha, um login antigo em outro dispositivo é desconectado automaticamente; a troca de nome de usuário reflete imediatamente em todas as telas onde o nome aparece (ex.: registros de atendimento, auditoria).

RF-16

Remoção de funcionalidade · Seção 8 do PRD — **decisão confirmada, ver Seção 3**

Solicitação: excluir a aba Faturamento.

Decisão confirmada: apenas a cobrança por sessão (já coberta pelo RF-08) é removida. A gestão da assinatura Stripe da clínica com o Behavior Hub (Seção 8.3) continua existindo, movida para dentro da tela "Planos" — a aba "Faturamento" em si deixa de existir no menu principal.

RF-17

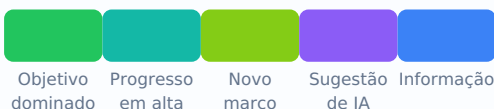
Transversal · Seção 5 e 24 do PRD (Design System)

Solicitação: deixar o visual dinâmico, agradável e com melhor leitura para todos — **e também mais alegre**, sem perder o tom profissional que o produto precisa ter para uso clínico.

Comportamento esperado: aplicar de forma consistente o Design System já definido (Seção 24), mas com uma injeção deliberada de leveza:

- Estados vazios com ilustração simples ou ícone amigável, não só texto cinza — o primeiro contato de uma clínica nova com o sistema deve parecer um convite, não uma tela quebrada.
- Uso mais generoso (mas ainda comedido) das cores de apoio da paleta — verde esmeralda, turquesa, verde-claro — em pequenos detalhes: ícones, indicadores de progresso, badges de conquista (ex.: "Objetivo dominado 🏆"), em vez de deixar tudo em tons de cinza e azul profundo o tempo todo.
- Cantos mais arredondados e espaçamento generoso nos cards (já previsto na Seção 24.8), reforçando a sensação de acolhimento em vez de "planilha".
- Microanimações curtas (transição suave ao trocar de aba, confirmação animada ao salvar) — nunca decorativas a ponto de atrapalhar quem usa o sistema várias vezes por dia.

Exemplo de uso mais expressivo da paleta em pequenos detalhes



Critério de aceite: revisão de design (mesmo que informal, print a print) confirmando contraste mínimo de 4.5:1 em texto padrão, navegação por teclado funcional nas telas principais, e presença de pelo menos um elemento de leveza visual (ilustração, cor de apoio ou microanimação) em cada tela principal do sistema.

3. Decisões Confirmadas (RF-07, RF-13, RF-16)

Os três pontos abaixo já foram respondidos e estão travados para desenvolvimento — não são mais perguntas em aberto.

RF-07 — Resolvido: nome fixo vindo da ficha do paciente

Confirmado: o campo Paciente na tela de atendimento é sempre texto fixo (somente leitura), preenchido automaticamente pelo contexto de navegação (RF-09) — nunca uma digitação livre. A especificação do RF-07 na Seção 2 já reflete esta decisão como definitiva, não mais como interpretação assumida.

RF-13 — Resolvido: esconder, não remover

Confirmado: a funcionalidade de Importação em Lote de Pacientes (Seção 32.7 do PRD v2.0) permanece no código, mas fica oculta do menu principal por padrão. Recomenda-se implementá-la atrás de uma feature flag por clínica (ex.: `feature_bulk_import_enabled`), liberável manualmente para clínicas Enterprise que precisem migrar de outro sistema, sem exigir um novo deploy para ativar.

RF-16 — Resolvido: só a cobrança por sessão sai

Confirmado: apenas a cobrança por sessão dentro da clínica é removida (coberto integralmente pelo RF-08). A gestão da assinatura Stripe do próprio Behavior Hub (plano contratado, forma de pagamento, próxima cobrança, Seção 8.3 do PRD) continua existindo no produto — recomenda-se movê-la para dentro da tela "Planos" já existente, em vez de manter uma aba própria "Faturamento" no menu principal, já que RF-16 pediu a remoção dessa aba especificamente.

4. Impacto no Modelo de Dados

Alterações e novas entidades necessárias em relação ao modelo de dados da Seção 18 do PRD v2.0:

Entidade	Alteração	Motivo
Patient	+ address, phone, school_name, school_shift	RF-03
TreatmentPlanArea (nova, ou campo em Objective/área)	+ attached_pdf_url, uploaded_by, uploaded_at	RF-04
Objective	+ ai_generated (bool), ai_source_document_id, ai_reviewed_at	RF-05
Assessment	+ ai_generated_plan_draft (referência a um TreatmentPlan em rascunho)	RF-06
Session	remover campos de valor/cobrança, se existirem	RF-08
TrainingPatientLink (nova)	training_id, patient_id, linked_by, linked_at, status (prescrito/aplicado)	RF-10
User	+ role "AT" no enum de papéis; + supervisor_id (para vincular AT a um supervisor)	RF-11
Resource	+ ai_generated (bool), ai_reviewed_at	RF-12
AuditLog	já suporta patient_id como entidade referenciada; adicionar índice patient_id + timestamp para a nova visão agrupada	RF-14

5. Impacto em Personas e Permissões

O papel **AT (Auxiliar Terapêutico)** passa a existir como uma quinta persona, complementando a tabela da Seção 2 do PRD:

Persona	Necessidade principal	Permissões esperadas
AT (Auxiliar Terapêutico)	Aplicar treinos prescritos em pacientes atribuídos, sob supervisão.	Ver pacientes atribuídos, ver treinos vinculados (RF-10), registrar tentativas. Sem acesso a diagnóstico completo, plano de tratamento ou relatórios, salvo liberação explícita do supervisor.

A tabela de RBAC da Seção 17.1 do PRD deve ganhar uma coluna "AT" ao lado das já existentes (Admin clínica, Profissional, Supervisor, Individual), com a maioria das ações marcadas como "Não" ou "Restrito ao atribuído".

6. Prompt Pronto para o Claude Code

Copie o texto abaixo e cole no Claude Code, no mesmo projeto onde o PRD v2.0 já foi implementado (ou está em implementação). Ajuste o texto entre colchetes conforme suas respostas na Seção 3.

Você vai implementar um conjunto de melhorias no Behavior Hub, descritas em detalhe no arquivo docs/Behavior_Hub_Addendum_v2.1.pdf deste repositório. Leia o documento inteiro antes de tocar em qualquer código – ele referencia seções específicas do PRD original (docs/Behavior_Hub_PRD_v2_Completo.pdf) que também devem ser consultadas sempre que houver dúvida de comportamento.

DECISÕES JÁ CONFIRMADAS:

- RF-07 (nome do paciente no atendimento): o campo Paciente é sempre texto fixo/somente leitura, preenchido automaticamente pelo contexto de navegação (o atendimento é sempre aberto a partir da ficha do paciente, RF-09). Nunca é um campo de digitação livre. O que é multiple-choice obrigatório é o Profissional/Terapeuta responsável.
- RF-13 (Importar Paciente): NÃO remover do código. Ocultar do menu principal por padrão e implementar atrás de uma feature flag por clínica (ex.: `feature_bulk_import_enabled`), liberável para clínicas Enterprise sem exigir novo deploy.
- RF-16 (aba Faturamento): remover apenas a cobrança por sessão dentro da clínica (RF-08). A gestão da assinatura Stripe da clínica com o Behavior Hub continua existindo, mas passa a viver dentro da tela "Planos" – a aba "Faturamento" em si é removida do menu principal.

COMO TRABALHAR:

1. Implemente os requisitos RF-01 a RF-17 na ordem do documento. Cada um tem um critério de aceite explícito – trate como teste automatizado sempre que fizer sentido (especialmente RF-03, RF-09, RF-10, RF-11, RF-14, RF-15).
2. Para os requisitos que envolvem IA (RF-05, RF-06, RF-12): a IA nunca publica conteúdo clínico sozinha. Todo conteúdo gerado precisa aparecer com indicação visual clara de que foi gerado por IA e aguardar confirmação explícita do profissional antes de virar dado ativo do sistema.
3. RF-11 introduz um novo papel de usuário (AT). Implemente isso como parte do sistema de RBAC já existente (Seção 17 do PRD), não como um sistema de permissão paralelo.
4. Ao final, rode os testes de regressão das fases já implementadas do PRD original – várias dessas mudanças tocam telas e regras que já tinham cobertura de teste (ex.: Seção 21.2, critérios AC-01 a AC-19).
5. RF-17 pede um visual mais dinâmico e alegre, não só "correto". Aplique o Design System (Seção 24 do PRD) com leveza deliberada: estados vazios com ilustração/ícone amigável, uso mais expressivo (mas comedido) das cores de apoio da paleta em badges e indicadores de progresso, cantos arredondados, espaçamento generoso e microanimações curtas – sem comprometer a leitura nem o tom profissional exigido por um sistema de uso clínico.
6. Se encontrar qualquer novo ponto ambíguo não coberto por este documento, pare e me pergunte antes de assumir um comportamento.

Me dê um resumo do que foi alterado, os comandos para testar localmente, e uma lista do que mudou visualmente para eu revisar antes de você seguir para qualquer tarefa nova.

